

פארום בר"ק

מובילים יחד הזדקנות מיטבית

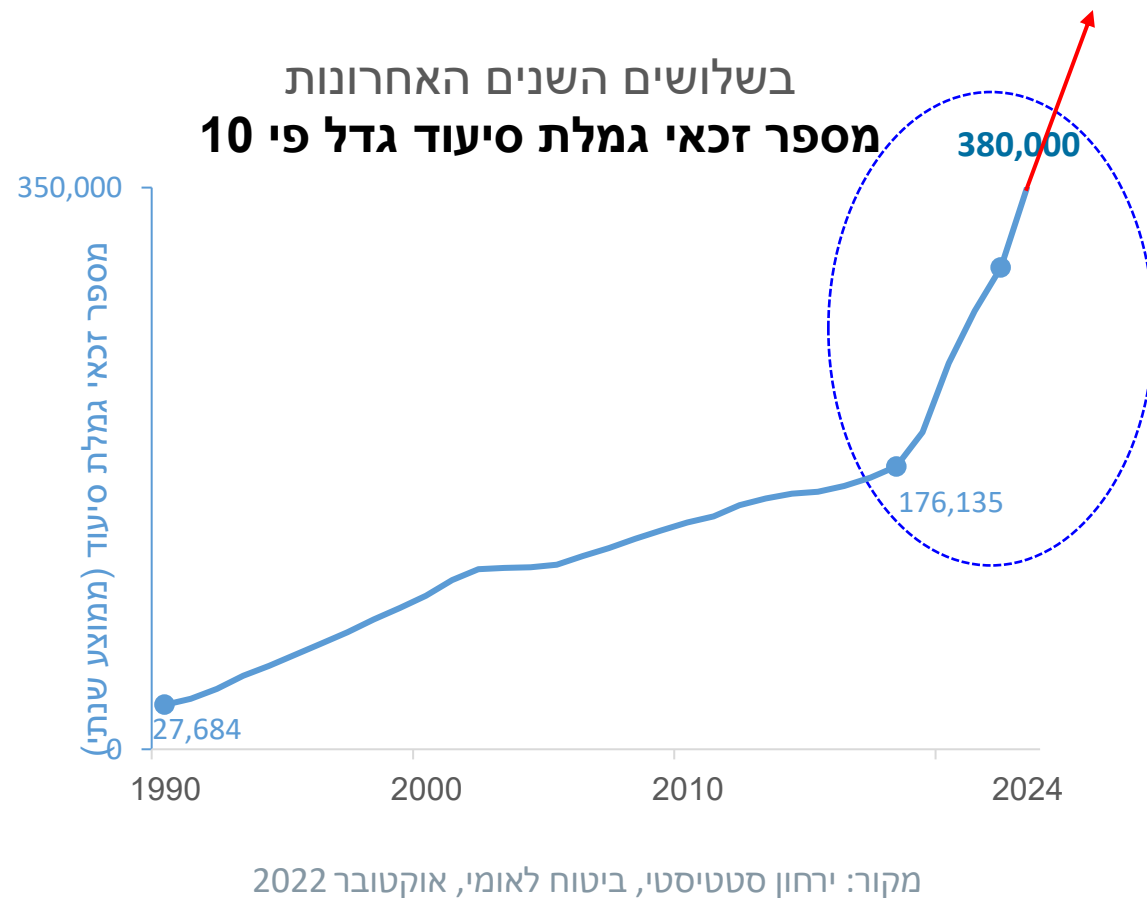
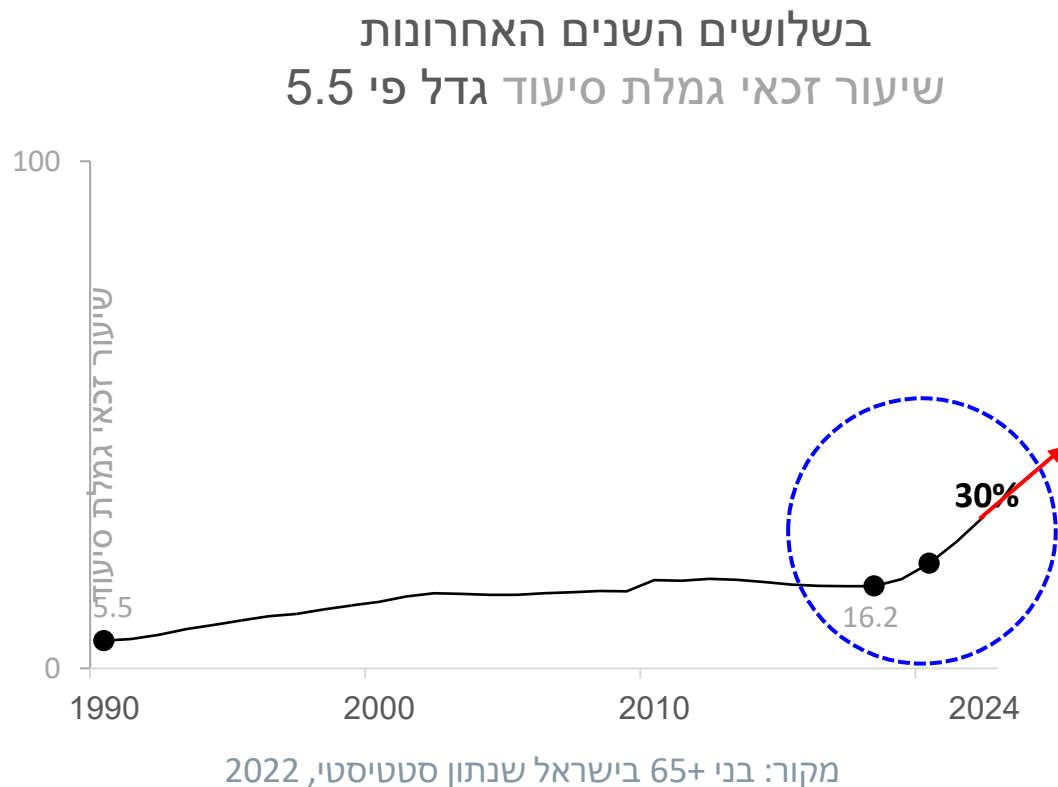


בריאות, ביטוח לאומי, רווחה, רשויות, קופות החולים

סדנת עיצוב שירות סל מותאם אישית

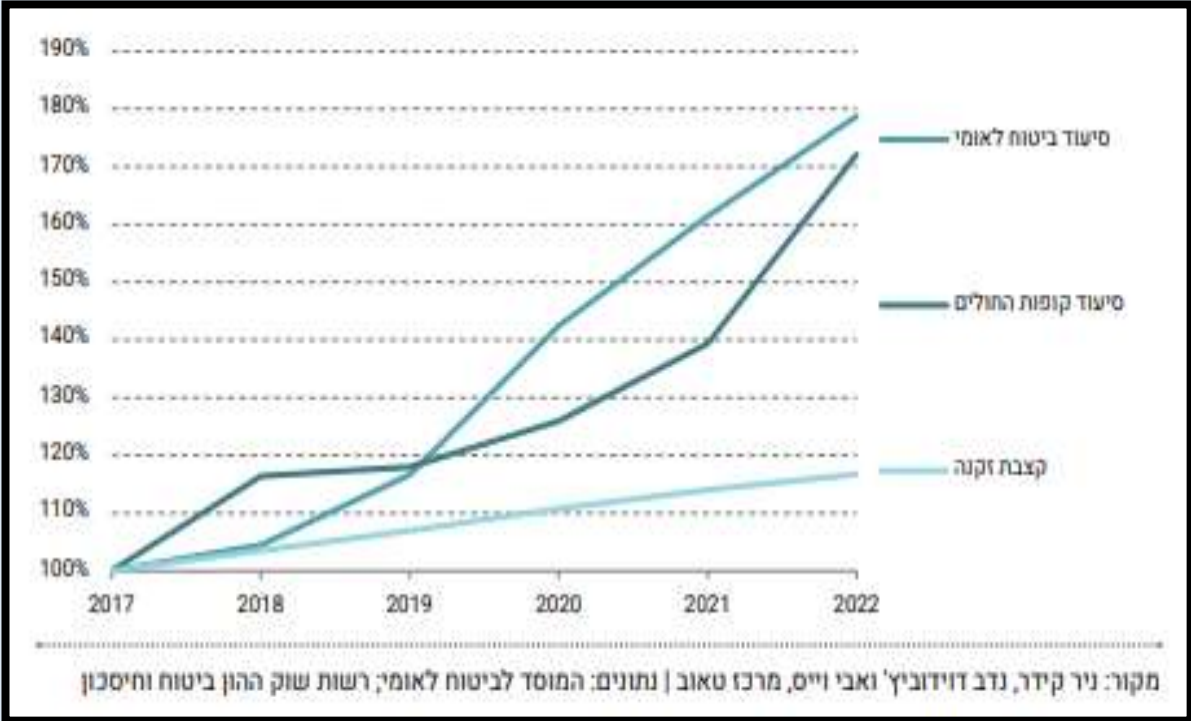
האתגר בסיעוד 2024

מספר ושיעור זכאי גמלת סיעוד לפי שנים

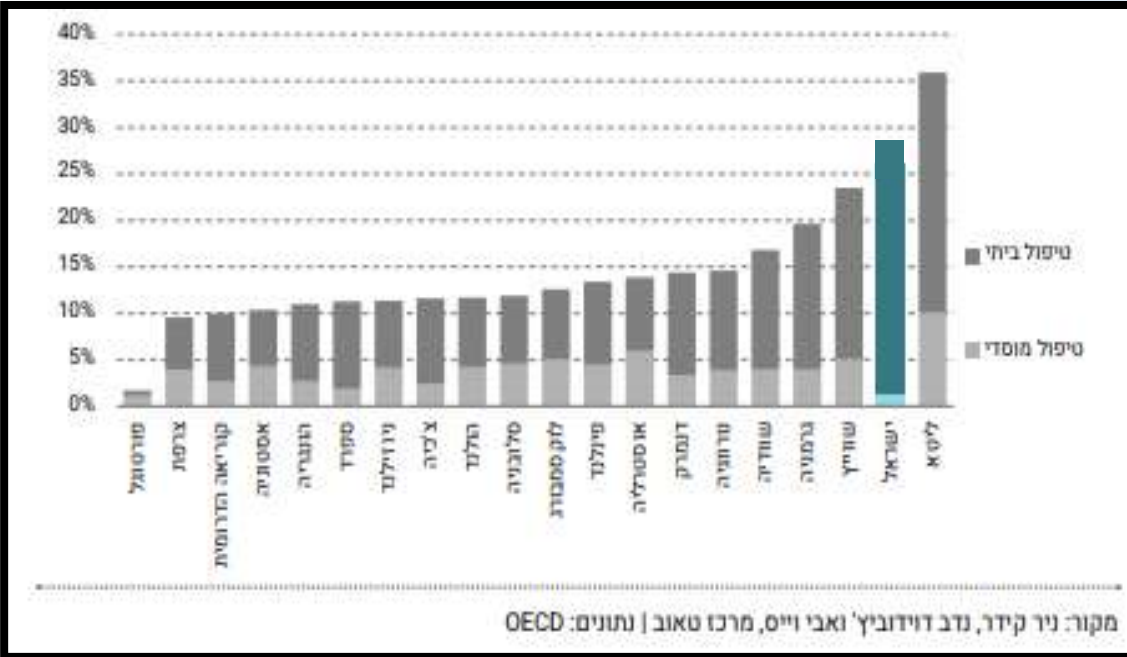


השוואה בין הגמלאות לזקנה והשוואה בינלאומית

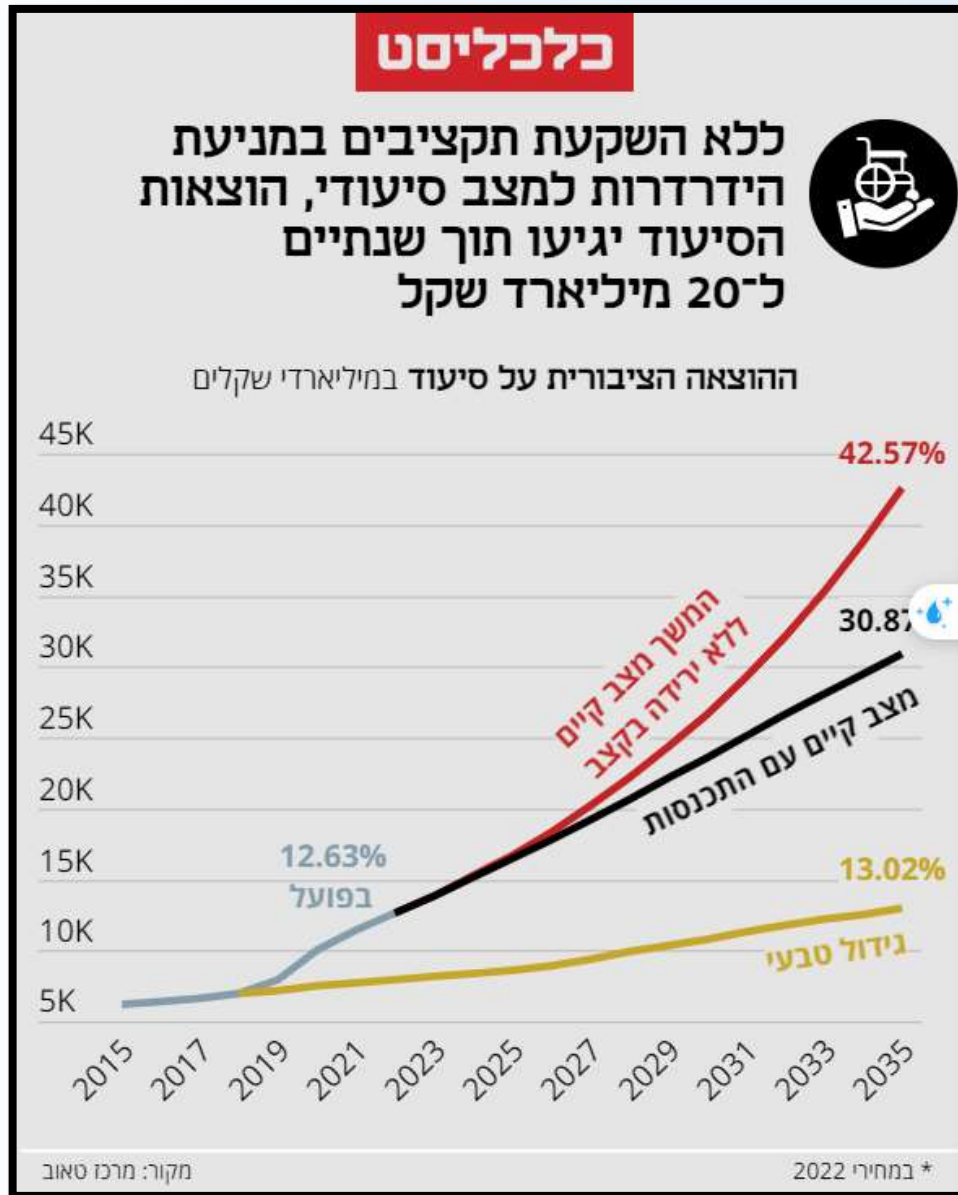
קצב גידול מקבלי גמלת סיעוד, ביטוח סיעודי וקצבת אזרח ותיק 2017-2022



שיעור אזרחים ותיקים מקבלי סיעוד בהשוואה בינלאומית 2020



ההשלכות והמשבר בסייעוד:



פרסום ראשון

כללית לבג"ץ: "אנו ניצבים בפני משבר קיומי למערכת הבריאות והסיעוד בישראל"

שקד גרין 17:08, 17.09.24

בלעדי

ענף בקריסה: אף חברת ביטוח לא ניגשה למכרז הסיעוד של הכללית

המשבר בביטוח הסיעודי מעמיק, כשקופת החולים עם מספר המבוטחים הגדול ביותר לא מצליחה למצוא מבטחת. הוינוק במקביל קצבאות הסיעוד הפך את התחום ללא-רווחי והמבטחות איבדו עניין. מנורה מבטחים נשארה שחקנית יחידה, אך אינה יכולה לבטח את כולם

שקד גרין 06:00, 28.08.24

חדשות • מדיה

ויתרה מראש? ביטוחי הסיעוד קורסים, והממשלה אינה נוקפת אצבע לעצור זאת

מכר הביטוח הסיעודי של קופת חולים כללית נכשל לאחר שאף חברת ביטוח לא ניגשה אליו ■ חברת הביטוח נוטשות את הענף בגלל הגידול המהיר במספר תביעות הסיעוד וחוסר היכולת שלהן לדחות תביעות ■ אם זה לא יטופל, ביטוחי הסיעוד יחדלו מלהתקיים

10

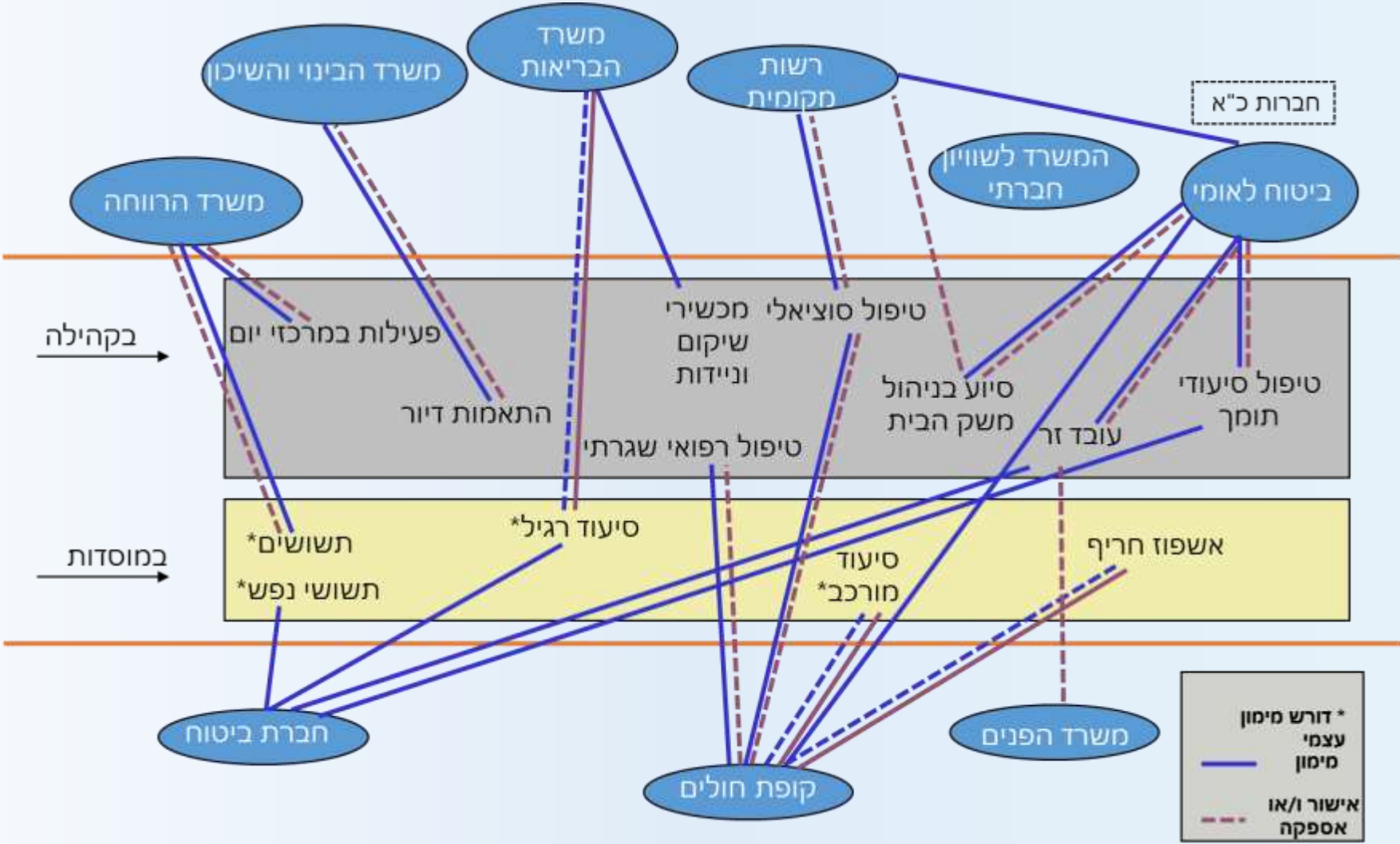
מיכאל ארדמונד

הסרת מידע

הסרת מידע



הפיצול בסיעוד



אתגרים בשדה ההזדקנות

פורום ברק הינו תולדה של ההבנה שקיימים בשדה אתגרי רוחב מערכתיים רבים שהתמודדות עימם מחייבת שיתופי פעולה בין ארגוניים.
תוחלת החיים מגדילה את כמות הזקנים הנזקקים והמערכת לא ערוכה להיקפים ולהשלכות.

האתגרים המרכזיים:

- **פרגמנטציה** של שירותים ומשרדים
- **היעדר השקעה מספקת במניעה**
- **צורך ברצף טיפולי** בין המערכות
- **התאמה והנגשה** של שירותים לצרכי האזרח
- **חסמים בשיתוף מידע** בין המערכות
- **מחסור בכח אדם** מקצועי וטיפולי בשטח
- **מחסור בתהליכי מדידה** מוכווני תוצאות





**במסגרת זו צוותי הפעולה של הפורום יהיו שותפים
ומעורבים בתכנון וגיבוש:**

- ✓ תמונת מצב, אתגרים והמלצות
- ✓ תכנית אסטרטגית משותפת
- ✓ ניירות מדיניות משותפים על נושאי מפתח
- ✓ תכנית עבודה רב שנתית משותפת
- ✓ הובלת מהלכים רב מערכתיים למענה לאתגרים
- ✓ חיבור בין המערכות שמביא לשיפור המענה והשירותים לאזרח

פורום ברק בגישה צופה פני עתיד

הפורום כתשתית אסטרטגית לעבודה רב מערכתית
שתוביל להיערכות משותפת להזדקנות מיטבית של
האוכלוסייה בישראל



מבנה ארגוני

פורום מנכ"לים 

מובילי פורום בר"ק 

4 צוותי עבודה 

צוות
מערכי
דיור 
*צוות מערכי דיור - בבדיקה להקמה

צוות
רשויות
מקומיות 

צוות
דאטה-דיגיטל 

צוות
מניעת
הדרדרות 

צוות מניעת הדרדרות מטרות



לקדם יישום והתאמות של
התפיסה במערכות השונות תוך
יצירת **ממשקי עבודה**
ושיתופי פעולה בין מערכתיים
בנושאי הליבה למניעת
התדרדרות

לייצר **תפיסה רב**
מערכתית משותפת
לשימור תפקוד ומניעת
הדרדרות

לפעול **לפיתוח כלי מדידה**
ותמריצים שיובילו למניעת
הדרדרות

להוביל יחד שינוי במדיניות,
במערכות ובמנגנון לטובת מניעת
הדרדרות והזדקנות מיטבית



מניעת הדרדרות הצוות



הרכב הצוות:

25 משתתפים ממגוון גופים:

משרד הרווחה
משרד הבריאות
הביטוח הלאומי
כל קופות החולים-כללית,
מכבי, מאוחדת ולאומית
עיריית תל אביב
עיריית ירושלים
הג'וינט

מנהל.ות הצוות:

- **נטלי גבאי -**
מנהלת אגף סיעוד, הביטוח הלאומי
- **ד"ר אפרת גיל -**
מנהלת המחלקה לשירותי קהילה
אגף גריאטריה, משרד הבריאות
- **אביעד יצחקי -**
ראש אגף תכנון מדיניות הזדקנות
האוכלוסייה, משרד הרווחה
והביטחון החברתי

מובילי צוות מדדים:

ד"ר רות מייטליס - משרד הרווחה
אסנת שמיר - משרד הבריאות
גלעד הדס - הג'וינט
ד"ר זוריאן רדומיסלסקי - קופ"ח
מכבי
ישי קום - קופ"ח מאוחדת
ד"ר שי בריל - קופ"ח כללית
יו"ר אקדמי: פרופ' רביע ח'לאילה
- סגן נשיא מכללת צפת

מלוות התהליך:

הדס ברזילי - הג'וינט

רכז הפורום:

חיים פרג - משרד הרווחה
והביטחון החברתי



השינוי הרצוי וקהל היעד

הבעיה שנרצה לפתור



האטת קצב ההידרדרות

ושמירת תפקוד לאורך

זמן בקרב אוכלוסיית

סיעוד 0-2

מדדי תוצאה ברמת הפרט

איך נראית הצלחה ברמת האדם



מדדי תפקוד פיזי

יציאה למרחב הציבורי
פעילות גופנית סדירה
היעזרות באמצעים תומכים
סביבה ביתית מותאמת

מדדי תפקוד קוגניטיבי

למידה לאורך החיים
עיסוק יצרני משמעותי
אוריינות דיגיטלית ושימוש
בדיגיטל

מדדי תפקוד חברתי

השתתפות חברתית
קיום רשת תמיכה
פונקציונאלית
שייכות למקום הגאוגרפי

יצירת השינוי

מנופי שינוי, סוכני הובלת שינוי



הביטוח הלאומי

בני משפחה

המטפלות

חברות סיעוד

קופות חולים

מסגרות קהילתיות
מתנ"ס, בתי תפילה..

שירותים חברתיים

משרדי הממשלה
הרלוונטיים

קידום מודעות
ורגולציה תומכת

הכשרות אנשי
מקצוע ומטפלים

שיתוף מידע בין
המערכות

פרקטיקות
מיטביות

הנגשת
הפעילויות

קידום מודעות והנעה
לפעולה

אל מול
המערכת

אל מול
פרט

מקרה בוחן - פנינה לוי, רמת סיעוד 2

(מייצגת כ-15% מהזקנים בישראל ברמות סיעוד הנמוכות)

בת 71, אלמנה, גרה עם בנה הגרוש



היום יום של פנינה מתאפיין ב:

קשיי תפקוד: פנינה יוצאת מעט מביתה

בדידות: פנינה מרגישה בודדה ומבודדת

תלות בבן: רגשות אשמה ועומס על הבן

חשש מפילות: מונע ממנה לצאת מהבית

האם הסל שפנינה צריכה לקבל זהה לכ160,000 זכאים ברמות הנמוכות?

מרכז יום?

שירותי כביסה?

כסף?

טיטולים?

מטפלת?





פנינה לוי, אישה בת 71, רמת סיעוד 2 (מייצגת 15% מהזקנים בישראל ברמות הנמוכות)

המלצות לסל מותאם לפנינה מצ'אט GPT:

- חיבור חברתי: פעילויות חברתיות בקהילה, מפגשים עם חברים, קבוצות תמיכה, פעילויות פנאי
- פיזיותרפיה: טיפולים לחיזוק השרירים, שיפור שיווי המשקל והתנועתיות, והפחתת הסיכון לנפילות
- טיפול רגשי: סיוע להתמודדות עם קשיים רגשיים, בדידות, דיכאון, וחששות
- הדרכה וייעוץ: הדרכה לבני המשפחה בנוגע לטיפול נכון בפנינה, ייעוץ בנוגע לזכויותיה והטבות המגיעות לה

מטרת סל השירותים:

- ✓ לשפר את איכות חייה של פנינה ולעזור לה לשמור על עצמאותה.
- ✓ להפחית את תחושת הבדידות והתלות בבן.
- ✓ לחזק את בריאותה הנפשית והפיזית.
- ✓ לאפשר לה ליהנות מחיים מלאים ומשמעותיים.



דגשים חשובים:

- סל השירותים המומלץ צריך להיות מותאם אישית לצרכיה הייחודיים של פנינה.
- רצוי שפנינה תהיה מעורבת בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לסל השירותים שיוענק לה.
- חשוב לתעד ולמדוד את התקדמותה של פנינה ולעדכן את סל השירותים בהתאם לצורך.

ממצאי מחקר השטח עם EY: תקציר עיקרי

1. חוסר מודעות לשירותים וזכויות:

- אזרחים ותיקים רבים אינם מודעים לשירותים הזמינים או מתקשים להבין כיצד להפיק מהם תועלת. המידע אינו נגיש בצורה ידידותית.
- יש צורך בשיפור הסברה והנגשת מידע על אפשרויות השירותים, כדי להבטיח שכל אזרח יקבל את המידע הדרוש לו.

2. מנגנוני הנגשה וייזום פרואקטיביים:

- השירותים אינם מגיעים בצורה יזומה לאוכלוסיות היעד, במיוחד באזורים עם פערים טכנולוגיים. יש לפתח מנגנונים יזומים שיוצרים קשר עם האזרחים במקום להמתין לפנייתם.
- צורך בשיפור תהליכי היישוג כדי להקל על אזרחים ותיקים לגשת לשירותים.

3. תמיכה מותאמת אישית:

- האזרחים זקוקים לליווי ותמיכה אישית מתמשכת, כולל מתאמות שירות שיסייעו להם בהכוונה לצריכת שירותים מותאמים ובהתאמות שוטפות.
- התמיכה האישית חייבת לכלול מענה דינמי ועדכון שירותים בהתאם לצרכים המשתנים.

4. שירותים מותאמים תרבותית ומגדרית:

- שירותים מותאמים צריכים לכבד את התרבות והמנהגים של אוכלוסיות שונות, כמו החברה החרדית והערבית. יש גם להתייחס להבדלים מגדריים בשימוש בשירותים.
- התאמות אלו יסייעו לשילוב טוב יותר של כלל האזרחים במערך השירותים.

5. תמיכה טכנולוגית:

- שירותים דיגיטליים יכולים לשפר את איכות החיים של אזרחים ותיקים, אך יש לגשר על הפערים הטכנולוגיים ולהעניק הדרכה מתאימה.
- חשוב לשלב טכנולוגיות מתקדמות בצורה פשוטה ונגישה, כך שכל אזרח ותיק יוכל להפיק מהן תועלת.

6. סיוע לנזקקים וזיהוי דגלים אדומים:

- יש צורך במערכות לניטור וזיהוי מוקדם של מצבים כמו בדידות, הידרדרות בריאותית, וסיכונים אחרים, כדי להבטיח התערבות מהירה ויעילה

עקרונות המודל החדש

1. גישה מוכוונת אדם:

- יצירת סל שירותים גמיש ומותאם אישית לכל אזרח ותיק, שמשלב תמיכה פיזית, חברתית וקוגניטיבית. הדגש הוא על מניעה ושימור תפקוד, עם אפשרות בחירה רחבה.

2. שירות קהילתי בסיסי לכל אזרח ותיק:

- שירותים חיוניים שכוללים פעילויות חברתיות, תיקונים בבית, מענה בטיחותי, ושירותי תחבורה בסיסיים.
- מתאמות שירות יובילו את תהליך התמיכה ויזמו פתרונות לפי הצרכים הקהילתיים.

3. סל שירותים מותאם אישית:

- סל שירותים מגוון לבחירה, הכולל: ליווי אישי, ייעוץ תזונתי, פעילות גופנית, קורסי אוריינות דיגיטלית, ותמיכה טכנולוגית.
- פלטפורמה דיגיטלית תעזור לנהל את הסל האישי, לעקוב אחר מדדים בריאותיים, ולהציע התאמות לפי הצרכים המשתנים.

4. שימוש בטכנולוגיות מתקדמות:

- פלטפורמה חכמה לניהול שירותים ומעקב, המאפשרת לזהות שינויים במצב בריאותי ולספק שירותים מניעתיים.
- שילוב AI לזיהוי מוקדם של הידרדרות ומתן התראות למתאמות השירות.

5. שיתוף פעולה בין-משרדי:

- תיאום בין משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, וקופות חולים ליצירת רשת שירותים רציפה.
- מעורבות של ארגוני מגזר שלישי לתמיכה ושיפור החיבור הקהילתי.



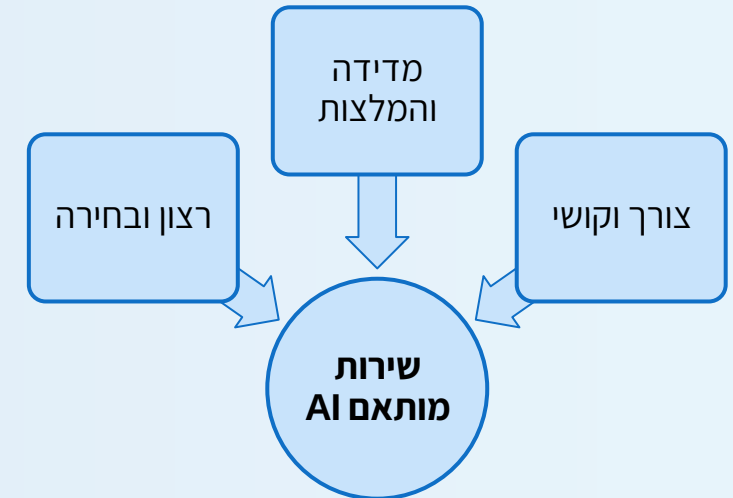
סל שירותים אישי

מעטפת שירותים לבחירת האזרח
הוותיק



סל מותאם אישית AI

מבוסס נתונים
לבחירת האזרח



מה יוצא לנו מזה?

הסל מותאם אישית יקדם:



ניהול ואסטרטגיה

גיבוש תמונת מצב מדויקת

התאמת מדיניות על בסיס נתונים

מדידת תוצאות ואימפקט

פתיחה ושיפור דינמיקת השוק



אפקטיביות

שיפור תהליכים ממשלתיים

זיהוי, תחזיות והערכת סיכונים

ייעול הטיפול באירועי חירום

ניהול יעיל וחסכון במשאבים

תמרוץ שירותים מועילים



הזדקנות מיטבית

הרחבת **עצמאות ובחירה, השתתפות,**
וקידום **שייכות ומשמעות**

שירותים מותאמים אישית
לאזרח הותיק ולאנשי המקצוע
מידע וכלים לניהול עצמי לאזרח
ולמשפחתו

מניעת התדרדרות תפקודית
והגדלת שנות החיים הבריאות

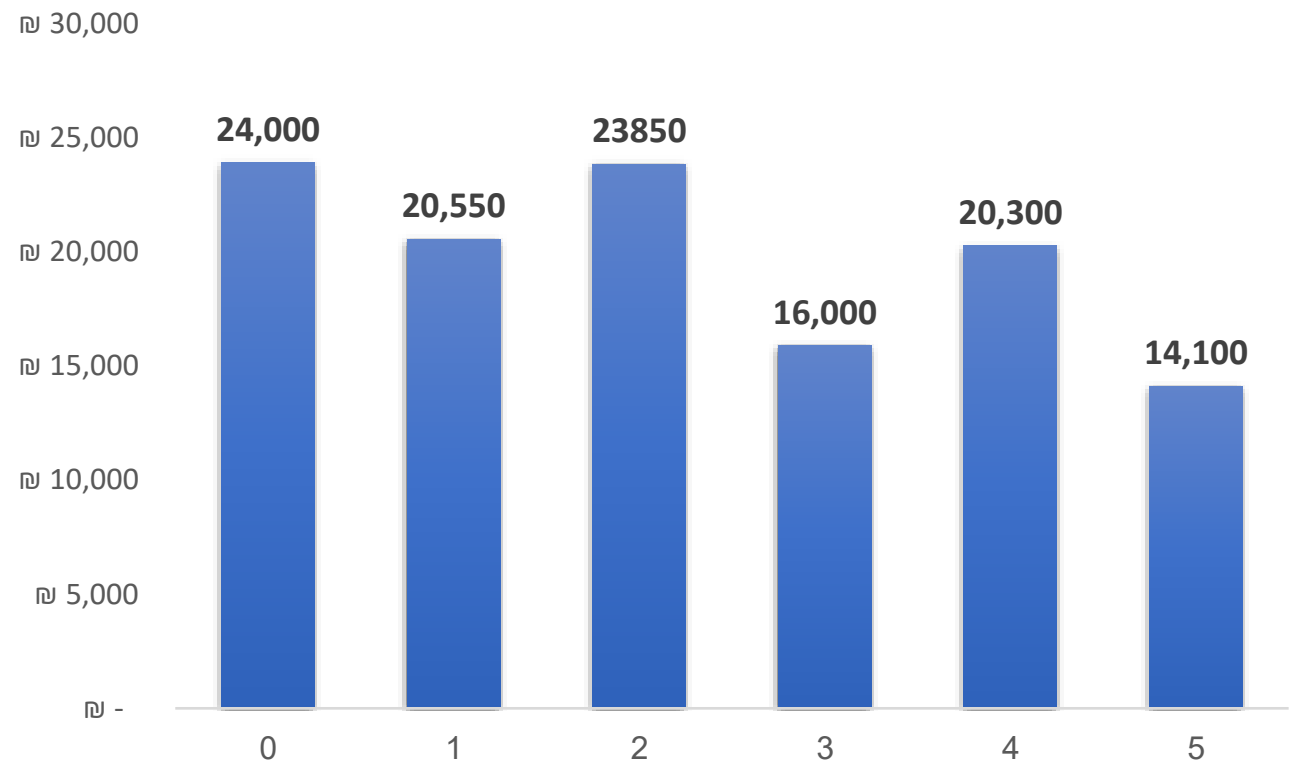
רפורמה עם חסכון תקציבי?!

במידה ונדחה בממוצע כ-3 חודשים
בעלייה ברמות סיעוד 0-2 =

מעל מיליארד ₪
חסכון למשק לשנה

(לא כולל ביטוחי סיעוד)
(חצי מהתקציב יושקע ברשויות שיצליחו למנוע?)

ROI במניעה לשנה לפי רמות סיעוד



*מבוסס על עלויות הגמלה
ועלויות בריאות בקופ"ח מאוחדת

הרכב גמלת הסיעוד במודל המוצע



רכיבי גמלת הסיעוד

במודל החדש מוצה להרחיב את השירותים הניתנים במסגרת גמלת הסיעוד כדי לאפשר יותר בחירה למקבל הגמלה. אלו הרכיבים מהם יוכלו הזכאים לבנות את תמהיל הגמלה – כך שניתן יהיה לייצר תמהילים ושנים בין הרכיבים בהתאם לצרכיו של מקבל הגמלה



קצבה בכסף



שירותי סיעוד

השירותים הקיימים כיום, כולל
שעות טיפול בבית, ולצידם
תוספת של שירותי ליווי/תמיכה
בניידות מחוץ לבית



שירותי הזדקנות מיטבית

ההמלצה לזכאים היא להמיר
לפחות 2 יחידות מהגמלה
לשירותי הזדקנות מיטבית –
כאשר נבחנת האפשרות לחייב
המרה של 2 יחידות מהגמלה

מודל השירות מתייחס לאופן
אספקת וצריכת שירותי הזדקנות
מיטבית בלבד

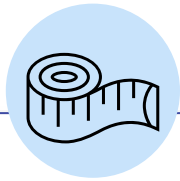


סל שירותי הזדקנות מיטבית

הסל מורכב משירותי הקהילה המקומית ועוד מבחר של שירותים בהתאמה אישית לצרכי מקבל השירות



שירותי מש"ח וקופ"ח
שירותים שמציעות המחלקה
לשירותים חברתיים וקופ"ח
באזור מגוריו של מקבל השירות
המתאימים לצרכיו של מקבל
השירות



שירותים מותאמים אישית
מגוון רחב של שירותים מותאמים
לצרכי מקבל השירות
כמו: חדר כושר, הרצאות בתחומי
דעת שונים, עזרים טכנולוגיים,
קורסי אוריינות דיגיטלית, טיולים
מודרכים, טיפוח ועוד



שירותי קהילה מורחבים
שירותים נוספים שניתן לצרוך
דרך הקהילה המקומית
שמרחיבים את שירות הבסיס,
מותאמים לצרכי הקהילה ולאזור
בה היא פועלת



שירות קהילה מקומית
קהילה בת 150 חברים
המתגוררים בסמיכות זה לזו אשר
מנהלת על ידי מתאמת שירות
ומספקת לחבריה שירותי בסיס
דוגמת פעילויות חברתיות, ביקורי
בית וכו'

איפיון נותני השירותים, תהליכי עבודה וממשקים



ספק שירותי קהילה/מחלקה לשירותים חברתיים*

הגורם המתפעל את שירותי הקהילה, בסיסיים ומורחבים, באזור מסוים ופועל באמצעות:



מנהלת קהילות

מנהלת 10 קהילות מקומיות, מנחה ומדריכה את מתאמות השירות, מטפלת במקרים מורכבים, מסייעת בבניית התוכנית הקהילתית



מתאמת שירות

מרכזת את פעילות הקהילה המקומית שמונה כ-150 חברים, דואגת לצרכי החברים בקהילה, מקיימת ביקורי בית, מארגנת פעילויות ועוד

*תתכן אפשרות שבחלק מהרשויות המקומיות שירותי הקהילה ובכלל זה מתאמת השירות ומנהלת הקהילות יסופקו באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ולא באמצעות מפעיל חציוני



פלטפורמה דיגיטלית

הפלטפורמה הדיגיטלית מהווה בעצם סוג של "מרקטפלייס" אליו יכולה האזרחית הוותיקה להיכנס ולבחור שירותים מתוך סל שירותי הזדקנות מיטבית (מתוך שירותי הקהילה המורחבים, השירותים המותאמים שמציעים ספקי השירות הכלליים ושירות מש"ח וקופ"ח באזור) בהתאם לרצונותיה, כאשר השירותים המוצגים לה לבחירה הותאמו לצרכיה הייחודיים



אזרחית ותיקה

זכאית לגמלת סיעוד בדרגות 1-2 וצורכת דרך הגמלה שירותי הזדקנות מיטבית



ספקי שירותים כלליים

מגוון רחב של ספקי שירות, ללא תלות בקהילה המקומית, אשר השירותים השונים שהם מציעים מרכיבים את השירותים המותאמים אישית. אלו יכולים להיות שירותים ייעודיים לאזרחים ותיקים או שירותים המסופקים לציבור הרחב שניתן יהיה לצרוך דרך גמלת הסיעוד

איפיון נותני ומקבלי השירותים (פרסונות)



מנהלת קהילות

- כל 10 קהילות מנוהלות על ידי אשת מקצוע עו"ס/גרונטולוגית
- מנהלת הקהילות מכשירה, מדריכה ומלווה את מתאמות השירות בכל תפקידיהן
- היא גם מלווה באופן צמוד מקרים פרטניים מורכבים.



מתאמת השירות

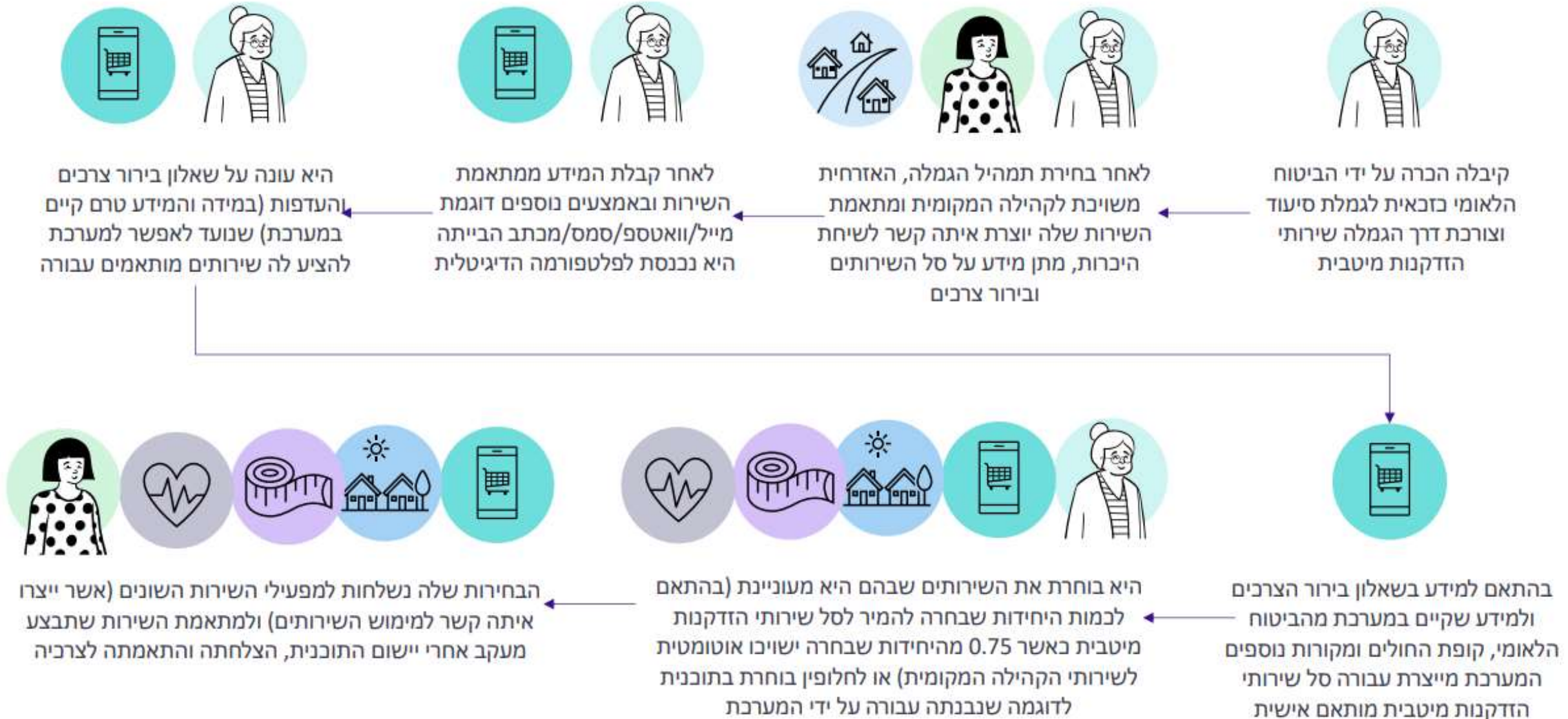
- מתאמת השירות מתכללת את עבודת הקהילה ונמצאת בקשר שוטף עם חברה
- היא בונה את תכנית הפעילות של הקהילה, כולל שירותי הקהילה המורחבים, ומעדכנת אותה אחת לחצי שנה על פי תוצאות המדידה והצרכים המשתנים של חברי הקהילה
- היא מסייעת למקבלי השירות לבחור את השירותים אשהם צורכים ואחת לחצי שנה מוודאת כי הסל מותאם לצרכי מקבל השירות



מאפייניי הקהילה

- הקהילה פועלת באזור מגוריו של מקבל השירות והוא משויך אליה בהתאם למקום המגורים
- הקהילה יכולה להיות מופעלת על ידי ספק חיצוני או על ידי הרשות המקומית
- היא מורכבת מ-150 מקבלי שירות
- הקהילה מנוהלת על ידי מתאמת השירות

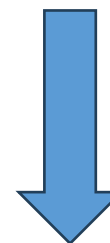
מסע הלקוח החדש



במה נעסוק:

חלק א':

- עיצוב ואיפיון שירות וסל השירותים
- עיצוב תהליכי עבודה וממשקים
- הגדרת פרסונות נותני ומקבלי השירותים



חלק ב':

- מסע לקוח חדש
- עקרונות הפיילוט



במה לא נעסוק:

- מי המשרד המתכלל/של מי המודל - של כולנו
- יעדים ומדדים - צוות מדיניות וצוות מדדים
- תמריצים - בעבודה עם EY
- העברות מידע בין מערכות - דיגיטאטה
- בניית תשתית טכנולוגית - דיגיטאטה
- תקציבים ורגולציה
- שיתוף ציבור

תוצרים מצופים

- תיקוף המודל
- קידום פיילוטים
- המשך עבודה בצוותי פעולה

ועדה בין משרדית וחוק ההסדרים:

- **ועדה בין משרדית:** "הרחבת שירותי הרווחה לזכאים וביסוס שירותי הקהילה תומכת - תקצוב משרד הרווחה באופן ייעודי למערך הקהילות התומכות, כך שכל זכאי לגמלת סיעוד ברמות הנמוכות יהיה זכאי גם באופן אוטומטי לשירותי קהילה תומכת".

מתוך חוק ההסדרים האחרון:

אימוץ מסקנות הצוות למניעת הדרדרות תפקודית

1. לאמץ את מסקנות הצוות למניעת הדרדרות תפקודית של אזרחים ותיקים (להלן – הוועדה למניעת הדרדרות), ולהנחות את שרי הרווחה, הבריאות והאוצר לפעול ליישומן.
3. להנחות את שר העבודה, בהסכמת שר הרווחה והביטחון החברתי ושר האוצר, לתקן את לוח ח'2, כך שיורחבו שירותי הקהילה התומכת, ויכללו בהם שירותים לבחירת האזרחים הוותיקים כגון צמצום בדידות, יצירת משמעות ושימור תפקוד גופני.

A person with a backpack is walking away from the viewer on a dirt path that leads towards a bright sunset. The sun is low on the horizon, creating a strong lens flare and reflecting its golden light on the calm water of a lake. The path is flanked by lush green hills and vegetation. The sky is filled with soft, golden clouds.

רפורמת סל אישי

בונים יחד את המחר של כולנו

"יחד, נוכל להפוך את מערכת הסיעוד בישראל למודל של חדשנות, יעילות ואיכות חיים - לא רק עבור הדור הנוכחי, אלא גם עבור הדורות הבאים."

תודה רבה
לשותפים
למסע!